

ITEM 190 : LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINÉ

Lupus érythémateux disséminé = lupus systémique : connectivite fréquente, protéiforme et spontanément grave, caractérisée par la production d'Ac anti-nucléaires, particulièrement dirigés contre l'ADN natif

- Parfois associé à un **syndrome des Ac anti-phospholipides (SAPL)** : thromboses récidivantes + Ac anti-phospholipides
- Prévalence = **1/2200** (maladie rare), prédominance féminine (**85%**), généralement en période d'activité génitale
- Plus fréquente et plus grave chez les **sujets non caucasiens** (noire, asiatique), notamment **Antillais**

Physiopathologie	Prédisposition génétique	- Concordance chez des jumeaux : 5% si dizygotes, 25-50% si monozygotes - Anomalies polygéniques : anomalie des cellules dendritiques, interférons, lymphocytes B et T, de la transduction du signal, de la transformation des complexes immuns et de l'immunité innée - Mutation monogénique prédisposant (exceptionnel) : déficit en voie classique du complément (C1q, C2, C4), surexpression d'interféron α...
	Facteur environnemental	- Rayons UV : favorise l'apoptose des kératinocytes - Virus (EBV surtout) : activateurs polyclonaux possédant des Ag proches de protéines du soi (Sm...) - Médicaments : minocycline, carbamazépine, interféron, anti-TNFα, β-bloquants - Facteurs hormonaux : oestrogènes - Silice
	Mécanismes cellulaires en cause	- Défaut de clairance des cellules en apoptoses → accumulation de débris cellulaires, notamment de corps apoptotiques contenant des Ag majeurs (chromatine et ses constituant : ADN natif, histone, nucléosome, ribo-nucléoprotéines (Sm, RNP, SSA, SSB), phospholipides membranaires) → captation par les cellules dendritiques → activation de lymphocytes T auto-réactifs contrôlant la sécrétion d'Ac par des lymphocytes B, dirigés contre ces Ag : production d'auto-Ac anti-nucléaires, détectables plusieurs années avant l'apparition des 1^{ère} manifestations - Dépôts d'Ac dans les tissus (directement ou après formation de complexes immuns) : inflammation locale et lésions tissulaires, entretenant le relargage de débris nucléaires - Boucles d'amplification : apoptose tissulaire excessive, ↘ clairance des cellules apoptotiques par les macrophages, hyperactivité des lymphocytes B et T, sécrétion de cytokines (IFN-α, IFN-γ, IL10, BlyS)
Manifestations cutanées	= 80% des cas : peuvent précéder les manifestations systémiques de plusieurs années	
	Lésions spécifiques = lupiques	- Photosensibilité : prédominante en zones photo-exposées, aggravé par les UV - Histologie = lésions de l'interface épiderme-derme : atrophie des corps muqueux, lésions des kératinocytes basaux et infiltrat lymphocytaire péri-vasculaire et/ou péri-annexiel - IFD : dépôts d'IgG, IgA ou IgM et/ou de complément (C1q, C3) à la jonction dermo-épidermique = bande lupique (bande épaisse et/ou granulaire), retrouvés aussi en peau saine photo-exposée (50%)
		Lupus aigu (20-60%) - Eruption érythémateuse, maculeuse ou maculo-papuleuse, finement squameuse, parfois oedémateuse, à bordure émettée, non prurigineuse - Localisé au visage, en vespertilio : symétrique sur le nez et les pommettes, en « ailes de papillon », avec respect du sillon naso-génien et des paupières - Parfois sur le décolleté, les doigts (face dorsale des zones interarticulaires, pulpite érosive) ou les muqueuses, notamment buccale (d'aspect érosif) → Accompagne les poussées de lupus, disparition rapide sans séquelle
		Lupus subaigu (10-20%) = Eruption annulaire ou polycyclique, plus rarement psoriasiforme - Touchant le décolleté et les membres, respectant habituellement le visage - Très photosensible - Evolue vers une dépigmentation séquellaire, généralement définitive - Associée à la présence d'Ac anti-Ro/SSA
		Lupus chronique (10-20%) - Lupus discoïde : plaques bien limitées, associant érythème télangiectasique, squames épaisses et atrophie cicatricielle, sur le visage (en vespertilio), les oreilles, parfois le cuir chevelu (avec alopecie définitive) ou les extrémités - Lupus tumidus : papules/nodules érythémateuses, infiltrées du visage - Lupus à type d'engelures des extrémités (chilblain lupus) - Panniculite lupique : nodule des faces externes des bras et cuisses, laissant une atrophie cicatricielle en dépression cupuliforme ou en « coup de hache »
	Lésions non spécifiques	- Lésions vasculaire inflammatoire (vascularite) ou thrombotique (SAPL) : syndrome de Raynaud, livedo racemosa, urticaire, purpura infiltré ± nécrotique, érythème violine des paumes, lésions pulpaire purpuriques, ulcère de jambe, gangrène distale - Chute des cheveux : fréquente lors des poussées, pouvant aboutir à une alopecie - Ulcérations buccales, linguales ou génitales lors des poussées

Manifestations rhumatologiques	= 80% des cas : souvent inaugurale, polymorphe, accompagnant ou non une poussée viscérale				
	Poly-arthrite	= Polyarthrite bilatérale symétrique , des petites articulations , migratrice - Atteintes fréquentes : MCP, IPP, carpes, poignets, genoux, chevilles - Non déformante → Sauf rhumatisme de Jaccoud (subluxation articulaire réductible par atteinte tendineuse) - Signes évocateurs (≠ polyarthrite rhumatoïde) : non destructrice, caractère migrateur et fugace, discordance entre la douleur et l'intensité des signes cliniques			
	Autres	- Arthro-myalgies simples - Ténosynovites, rupture tendineuse - Ostéonécrose aseptique (même sans corticothérapie) - Atteintes musculaires (généralement cortico-induites) : myosite (↗ CPK), myalgies			
Manifestations rénales	= 40% des cas : inaugurale ou au cours de la 1 ^{ère} année dans 50% des cas, souvent asymptomatique (dépisté à la BU) - Manifestations : protéinurie glomérulaire (parfois minime), hématurie microscopique , syndrome néphrotique généralement impur , voire glomérulonéphrite rapidement progressive - Ponction-biopsie rénale indiquée si : - Protéinurie > 0,5 g/j - Hématurie microscopique associée à une protéinurie 				

Autres manifestations cliniques	Neurologique (30-60%)	SNC	Atteinte focale	- AVC, essentiellement ischémique (SAPL) - Neuropathie crânienne : nerf VI, III, V sensitif, VII, II... - Atteinte médullaire (souvent grave) : myélopathie ischémique ou myélite - Mouvements anormaux, notamment chorée (parfois révélatrice chez l'enfant)	
			Atteinte diffuse	- Troubles cognitifs : fréquent, généralement mineurs (rares états démentiels) - Encéphalopathie : syndrome confusionnel, troubles de conscience - Trouble psychiatrique (parfois grave, révélateur) : trouble psychotique, trouble de l'humeur grave → bonne réponse aux corticoïdes - Crise comitiale (surtout si SAPL associé) : généralisée ou partielle → Aspect souvent normal en IRM, ou parfois lésions étendues de la substance blanche hémisphérique	
			Autres (rares)	- Vascularite cérébrale (rare) : encéphalite aiguë/subaiguë fébrile - Migraine fréquente - Dysautonomie - Méningite lymphocytaire (doit faire rechercher une infection opportuniste)	
		SNP (rare)	- Multinévrite ou autre neuropathie périphérique variable - Syndrome myasthéniforme ou polyradiculonévrite associée		
	Cardiaque	- Péricardite (30%) : parfois révélatrice, fréquemment latente, très cortico-sensible - Myocardite (rare) : insuffisance cardiaque congestive, troubles du rythme, trouble conducteur - Valvulopathie mitrale ou aortique = endocardite de Libman-Sacks : épaississement diffus ou localisé, fortement associée à un SAPL, risque de complication = embolie artérielle, notamment cérébrale, dégradation hémodynamique, greffe oslérienne - Insuffisance coronarienne : par athérosclérose accélérée (corticothérapie) et/ou thrombose (SAPL)			
	Atteinte vasculaire	- Phénomène de Raynaud (35%) : parfois inaugural, rarement compliqué - HTA (30%) : souvent présente en cas de glomérulopathie grave, de forte corticothérapie, voire de micro-thromboses intra-rénales provoquant une HTA maligne - Thromboses veineuses, artérielles et micro-vasculaires : fréquente, parfois révélatrice, fortement associée à la présence d'Ac anti-phospholipides, spontanément récidivante - Micro-vascularite cutanée, parfois suggestive de périartérite noueuse			
	Respiratoire	- Pleurésie (25%) : uni- ou bilatérale, exsudative lymphocytaire, parfois latente, très cortico-sensible - Atteinte pulmonaire (15%) : toux, dyspnée, parfois hémoptysies ou anomalies auscultatoires, avec infiltrats non systématisés migrants ou atélectasie sous-segmentaire à la RP - Plus rarement : - Pneumopathie aiguë hypoxémiante - Pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante - Hémorragie intra-alvéolaire - Bronchiolite oblitérante - HTAP (rare) : primitive ou compliquant des migrations pulmonaires répétées d'embolies			
	Autres	- Signes généraux (surtout en poussée) : fièvre, asthénie, amaigrissement, ADP, splénomégalie - Douleurs abdominales, de mécanisme varié : péritonite lupique, pancréatite, perforation intestinale, thrombose viscérale, insuffisance surrénale, hémorragie sous anticoagulant... - Hépatomégalie modérée, plus rarement association avec une hépatite auto-immune de type 1 - Oculaire : rétinite dysorique aspécifique, neuropathie optique, thromboses de vaisseaux rétiens - Association fréquente à un syndrome de Gougerot-Sjögren			
	Manifestations biologiques	Non spécifiques	Bilan inflammatoire	- Lors des poussées : ↗ fibrinogène, ↗ orosomucoïde → CRP peu élevée, sauf en cas de sérite ou d'infection concomitante - VS souvent accélérée, d'origine multifactorielle - Hypergammaglobulinémie persistante, essentiellement à IgG	
NFS				Anémie	- Inflammatoire : lors des poussées marquées - Hémolytique auto-immune (test de Coombs direct positif à IgG + complément dans 5-10% des cas) : souvent cortico-sensible, parfois révélatrice - Autre (plus rare) : carence martiale, insuffisance rénale, érythroblastopénie auto-immune, microangiopathie thrombotique, syndrome d'activation macrophagique
					- Leucopénie fréquente (> 50%), modérée : lymphopénie T ± neutropénie - Thrombopénie auto-immune (15 à 25%, lors des poussées) : souvent latente, parfois à l'origine d'un purpura, rarement d'hémorragies viscérales, non toujours cortico-sensible
Hémostase			- Anticoagulant circulant de type lupique : associé dans 25% des cas		

Manifestations biologiques	Spécifiques	Ac anti-nucléaires	= AAN : constant, mais peu spécifique d'un lupus - Dépistage par IFI sur cellules Hep2 : seuil de positivité = titre $\geq 1/160$ - Aspect: - Homogène : plus fréquemment - Moucheté : anti-Ag nucléaire soluble - Périphérique : plus spécifique des Ac anti-ADN - Nucléolaire : sclérodermie surtout
		Ac anti-ADN natifs	= Ac anti-ADN bi-caténaire (double brin) : peu sensible, mais très spécifique - Test ELISA (sensible), test radio-immunologique de Farr (spécifique) ou IF sur <i>Crithidia luciliae</i> - Retrouvé dans 60% des cas, notamment pendant la phase active → Test de Farr : corrélé à l'existence d'une atteinte rénale grave et à l' évolutivité
		Ac anti-Ag nucléaires solubles	- Ac anti-Sm : peu fréquent (20%), très spécifique - Ac anti-Ro/SSA ou anti-La/SSB : plus rare, rencontré surtout dans le lupus subaigu et néonatal ou en cas de syndrome de Sjögren associé - Ac anti-ribonucléoprotéine (RNP) : présent dans 30% des cas, surtout dans les formes bénignes
		Autres auto-anticorps	- Ac anti-nucléosome (récent) : très spécifique, meilleure sensibilité que les Ac anti-ADN double brin, détectable en dehors des poussées, aussi corrélés à la gravité de l'atteinte rénale → A rechercher en cas de suspicion de lupus sans Ac anti-ADN ou d'emblée - Ac anti-histone : fréquent (80% des cas), notamment en cas de lupus induit (95% des cas) - Cryoglobulinémie : souvent de type III (polyclonale) - Souvent rencontrés : FR (20%), Ac anti-hématies , anti-plaquettes , anti-lymphocytes , anti-polynucléaires , anti-phospholipides
		Dosage du complément	= Hypocomplémentémie fréquente, prédictive d'atteintes viscérales graves (rénale , vascularite) - Consommation par les complexes immuns circulants ou tissulaires : $\searrow$ CH50, $\searrow$ C3, $\searrow$ C4 - Déficit constitutionnel prédisposant : $\searrow$ C2, C4, C1q, C1r, C1s
Formes cliniques	Lupus induit	= Secondaire à l'administration prolongée d'un médicament : - Principalement : isonazide , phénothiazine , quinidine , anticonvulsivants , β-bloquants , minocycline , interféron-α , anti-TNFα , antithyroïdien de synthèse , α-métyldopa , procaïnamide - Manifestations articulaires , pleuro-pulmonaires et/ou péricardiques avec signes généraux variables - Généralement sans atteinte cutanée, rénale, neurologique, Ac anti-ADN natif et hypocomplémentémie - Oestroprogestatifs : souvent responsable de poussées lupiques et/ou de thromboses → A évoquer surtout chez l'homme ou le sujet âgé > 50 ans	
	Formes intriquées	- Coexistence fréquente avec un syndrome de Gougerot-Sjögren - Association simultanée ou successive d'un lupus et d'une autre connectivite : syndrome de Sharp (phénomène de Raynaud, doigts boudinés, polyarthrite, myalgies, titre élevé d'AAN mouchetés anti-U1-RNP), pouvant évoluer vers une connectivite définie (lupus , sclérodermie , PR , dermatomyosite)	
	Grossesse	- Risque de poussée lupique important si : maladie évolutive au début de grossesse ou néphropathie - Grossesse autorisée si : rémission > 6 mois et fonction rénale normale ou peu altérée - Risques fœtaux : - Présence d'anticoagulant maternel : avortements itératifs , mort fœtale - Lupus néo-natal (lié à la présence d'Ac anti-Ro/SSA passant la barrière placentaire) : BAV complet , éruption cutanée néonatale transitoire , hépatite , thrombopénie - Risques de prématurité , de retard de croissance et mortinatalité accrus	
Diagnostic	Critères de l'ACR	Diagnostic si 4 critères simultanés ou successifs (Se et Sp = 95%) : non utilisé en pratique courante - Rash malaire - Lupus discoïde - Photosensibilité - Ulcérations orales ou nasopharyngées - NFS : anémie hémolytique , leucopénie , lymphopénie ou thrombopénie - Bilan immun : Ac anti-ADN natif , anti-Sm , anticoagulant circulant type lupique ou anti-cardiolipine , ou sérologie syphilitique dissocié - Titre anormal d' Ac anti-nucléaires en l'absence de drogues inductrices - Arthrite non érosive touchant ≥ 2 articulations périphériques - Pleurésie ou péricardite - Protéinurie > 0,5 g/j ou cylindrurie - Convulsions ou psychose	
Evolution	- Evolution par poussées entrecoupées de périodes de rémission - Facteur de mauvais pronostic : début pédiatrique, sexe masculin ou sujet à peau noire - Atténuation de l'activité de la maladie après la ménopause		
	Suivi	- Au diagnostic : bilan complet dont sérologie VIH, VHC, parvovirus B19 , recherche d'APL et ETT - Surveillance biologique : VS/CRP , NFS , iono , créat , C3 , C4 , CH50 , anti-ADN natif , glycémie , bilan lipidique - Recherche régulière de protéinurie , hématurie et leucocyturie → Nouvelles recommandations : NFS , créatininémie , BU (au moins tous les 3 mois), bilan hépatique , Ac anti-ADN natif , complément (C3, C4) , taux sanguin de Plaquenil® + glycémie et bilan lipidique 1 fois/an - En cas de réapparition d'anomalies immunologiques après une période de normalisation : risque d'exacerbation clinique → surveillance rapprochée , sans modification thérapeutique	

TTT	A court/ moyen terme	- Forme cutanée limitée (lupus subaiguë ou lupus discoïde) : dermocorticoïdes - Forme cutané-articulaire : - Hydroxychloroquine + AINS ± Faible corticothérapie dans les formes articulaires - Forme résistante : méthotrexate, voire belimumab (Ac anti-BAFF) - Forme viscérale : corticothérapie - Poussée grave : - Bolus de corticoïdes : méthylprednisolone 0,5 à 1g, IV, sur 90 min pendant 3 jours ± Immunosuppresseur	
		Cortico-thérapie	= Prednisone (Cortancyl®) : corticoïde de référence - TTT d'attaque = 3 à 6 semaines: - 1 mg/kg/j dans les formes graves = glomérulonéphrite proliférative diffuse, thrombopénie ou anémie auto-immune - 0,5 mg/kg/j dans les sérites - Diminution progressive de 10% tous les 10 à 15 jours - TTT d'entretien = 0,10 à 0,20 mg/kg/j : souvent maintenu plusieurs années
			Mesures d'accompagnement - Régime hyposodé, restriction glucidique et calorique - Supplémentation potassique en cas de fortes doses - Supplémentation en vitamine D ± calcium ± biphosphonates - Dépistage et traitement des foyers infectieux latents - Prophylaxie d'anguillulose selon contexte
		Immuno-suppresseur	= Limité au formes viscérales graves (atteinte rénale à type de glomérulonéphrite proliférative ou forme neurologique sévère) ou cortico-dépendantes - Cyclophosphamide en IV discontinuée : 0,5 à 0,8 g/m² tous les mois pendant 6 mois ou 500 mg tous les 15 jours pendant 3 mois - Puis : - Azathioprine : 2-3 mg/kg/j <i>per os</i> - Mycophénolate mofétil : 20-40 mg/kg/j <i>per os</i> - Durée totale minimale > 2 ans
		Biothérapie	= Dans les formes réfractaires ou cortico-dépendantes : en dernière intention : - Sans atteinte rénale, neurologique ou cytopénie auto-immune : belimumab - Avec atteinte rénale, neurologique et/ou cytopénie auto-immune : rituximab, thalidomide
	A long terme	Hydroxy-chloroquine Plaquenil®	= Antipaludéen de synthèse: indispensable, indication systématique (sauf contre-indication) - Posologie : 400 mg/j si fonction rénale normale - Risque de toxicité rétinienne après traitement prolongé, imposant l'arrêt du traitement - Surveillance ophtalmologique après instauration puis 1/an si FdR ou > 5 ans d'exposition : examen ophtalmologique avec FO et champ visuel central automatisé, vision des couleurs et un examen entre électrorétinogramme multifocal, FO en auto-fluorescence ou OCT spectrale
		Mesures associées	- ALD 30, PEC à 100% - Photo-protection efficace : port de vêtement et écran solaire d'indice élevé - Auto-surveillance par bandelettes urinaires - Arrêt du tabac (aggrave un lupus cutané) - Contrôle des FdRCV - Programme vaccinal : mise à jour du calendrier vaccinal + vaccin anti-pneumocoque et antigrippal en cas de traitement corticoïde ou immunosuppresseur
		Thrombopénie périphérique	= En cas de thrombopénie sévère cortico-résistante : - Immunoglobulines IV à fortes doses en situation d'urgence - Rituximab ou splénectomie
	Cas particuliers	Grossesse	- Planification : rémission > 6 mois, sans atteinte rénale (ou minime) - Poursuite de l'hydroxychloroquine ± faible corticothérapie (5-10 mg/j) - En cas d'immunosuppresseur : seul l'azathioprine ou la ciclosporine sont autorisés - Traitement associé si SAPL : aspirine à dose antiagrégant, HBPM préventive - Surveillance multidisciplinaire mensuelle
		Contraception	- Eviter les oestrogènes, surtout en cas d'antécédent de thrombose - Alternative : microprogestatif, acétate de chlormadinone (Luteran®), acétate de cyprotérone (Androcur®), DIU
Pronostic	→ Polymorphisme évolutif extrême - Survie à 10 ans = 80-90% - FdR de mauvais pronostic : début dans l'enfance/adolescence, néphropathie grave, atteinte neurologique centrale - Cause de décès : infection opportuniste, accident neurologique, insuffisance coronarienne, IRC - Risque augmenté de néoplasie, notamment de lymphome		

SYNDROME DES ANTI-PHOSPHOLIPIDES

SAPL = association de manifestations thrombotiques ou obstétricales, et de la présence durable d'un Ac anti-phospholipide

- **Ac anti-phospholipide** : interaction avec les phospholipides membranaires plaquettaires et les cellules endothéliales → activation de la coagulation
- Epidémiologie mal connue : prévalence = 1/2200, surtout chez la femme jeune (4/1), **1^{ère} cause de thrombophilie acquise**
- **Primaire** ou associé à une **connectivite**, essentiellement un **lupus systémique** (prévalence de **20 à 30%** au cours du lupus)

Diagnostic	C	Thrombose	- Evocateur : - Thrombose veineuse périphérique récidivante - De topographie inhabituelle (veine cave, membres supérieurs) - Embolies pulmonaires - Association de thromboses veineuses et artérielles (30%) → Les récides surviennent volontiers dans le même type de vaisseaux (veineux ou artériel)
		Neurologique (35%)	- AVC/AIT : par thrombose artérielle ou migration d'embolie cardiaque, volontiers corticaux ou sous-corticaux, multiple, récidivant - Démence vasculaire avec atrophie corticale - Thrombophlébite des sinus veineux cérébraux : céphalées, HTIC - Myélopathie vasculaire - Association avec chorée et/ou comitialité → Syndrome de Sneddon = AVC récidivant + livedo : > 50% associé à un SAPL
		Cardiaque	- Valvulopathie mitrale ou aortique = endocardite de Libman-Sacks : risque d'embolie artérielle ou greffe oslérienne, rare évolution vers l'insuffisance cardiaque - Thrombose coronaire : infarctus du sujet jeune - Cardiopathie ischémique
		Cutanée	- Livedo racemosa : coloration bleue-violacée de la peau, en forme de maille, à filets larges, irrégulières, ouvertes - Ulcères cutanés artériels - Orteils violacés, thromboses et nécroses cutanées - Hémorragie sous-unguéale en flammèche - Perforation de la cloison nasale
		Rénale	- Néphropathie glomérulaire : HTA, protéinurie, voire insuffisance rénale, parfois asymptomatique - Infarctus rénal ou sténose des artères rénales - Microangiopathie thrombotique
		Pulmonaire	- Embolies pulmonaires - Hémorragies intra-alvéolaires (capillarite par thrombose des artéioles alvéolaires) - HTAP post-embolique ou par thrombose <i>in situ</i>
		Digestive	- Hépatique : syndrome de Budd-Chiari - Ischémie intestinale aiguë ou angor mésentérique
		Surrénalienne	- Nécrose hémorragique des surrénales, souvent bilatérale, secondaire à une thrombose des veines surrénaliennes = syndrome d'Acherson : douleur abdominale, hypotension
		Oculaire	- Atteinte ophtalmique vasculaire : amaurose, OACR, NOIAA, OVCR
		Manifestation obstétricale	- Mort fœtale inexplicée par thrombose placentaire - Insuffisance placentaire : risque de prééclampsie, voire éclampsie - Fausses couches à répétition - Thrombose veineuse ou artérielle maternelle - HELLP syndrome
	Bio	NFS	- Thrombopénie (20% des cas, généralement modérée) et/ou anémie auto-immune
		Ac anti-phospholipide	- ELISA (IgG ou IgM) : - Anticardiolipine : spécifique, peu sensible - Anti-β2-glycoprotéine 1 : plus sensible - Dissociation de la sérologie syphilis (VDRL+/TPHA-) liée à l'Ac anticardiolipine - Anticoagulant circulant : - Allongement isolé du TCA et du temps de reptilase - Non corrigé par le plasma témoin - Corrigé par un excès de phospholipides → En présence d'un anticoagulant circulant, on ne peut pas utiliser le TCA pour adapter l'HNF, mais uniquement une héparinémie (activité anti-Xa)

Diagnostic	DD	= Circonstances associées à la présence d'Ac anti-phospholipide (sans risque thrombotique) : - Néoplasie (risque thrombotique lié au cancer) - Médicament inducteur d'Ac antiphospholipides (≈ médicaments inducteurs de lupus) : phénothiazine, phénytoïne, quinidine/quinine, interféron α, oestrogènes, β-bloquant, anti-TNFα, éthosuccimide, chlorothiazide, hydralazine, procainamide - Insuffisance rénale chronique - Maladie auto-immune : sarcoïdose, artérite à cellules géantes, périartérite noueuse, MICI - Hépatopathie - Infection VIH, infection VHC	
	Critères		→ Diagnostic si ≥ 1 critère clinique + ≥ 1 critère biologique
		Critère clinique	- Thrombose vasculaire : ≥ 1 épisode thrombotique artériel, veineux ou micro-vasculaire - Morbidité obstétricale : - ≥ 1 mort fœtale inexplicée après 10 SA - ≥ 1 naissance prématurée < 34 SA par éclampsie/prééclampsie - ≥ 3 fausses couches consécutives < 10 SA inexplicées
Critère biologique		= Retrouvé à 2 reprises à 12 semaines d'intervalles : - Anticoagulant circulant type lupique - Ac anticardiolipide (IgG et/ou IgM) à titre intermédiaire ou élevé (> 40) - Ac anti-β2-GP1 (IgG ou IgM) à titre élevé	
Formes cliniques	Syndrome obstétrical pur	- Événement obstétrical associé à des antiphospholipides - Sans thrombose authentifiée → Risque ultérieur d'événement thrombotique , surtout artériel	
	Syndrome catastrophique des Ac anti-phospholipides	= Orage thrombotique = microangiopathie thrombotique : rare (1% des SAPL), inaugural dans 50% des cas, mortalité élevée = 35% - Défaillance multiviscérale dans un temps limité (≤ 7 jours), sans sepsis ni fièvre, avec thrombopénie - Thromboses multiples : insuffisance cardiaque par cardiopathie, insuffisance rénale par atteinte vasculaire diffuse, encéphalopathie, détresse respiratoire, hypotension - Nécessité d'une preuve histologique - Facteur déclenchant : - Arrêt intempestif de l'anticoagulation - Stimulation de l'endothélium : chirurgie, geste artériel invasif - TTT en urgence : anticoagulation, corticoïdes et échanges plasmatiques	
TTT	SAPL prouvés	Thrombose	- TTT curatif : héparine - AVK à vie : objectif d'INR à 2,5 (veineux) ou 3 (artériel) - Si récurrence sous AVK : ajout d'aspirine à dose antiagrégant ou ↗ objectif d'INR à 3,5
		Obstétrical	- Aspirine à vie
	Prévention	= Anti-phospholipide durable sans manifestation thrombotique ou obstétricale - Associé à un lupus : aspirine à vie - Sans contexte de lupus : aspirine à discuter	
	Grossesse	- Si SAPL biologique : aspirine jusqu'au 8 ^e mois - Si SAPL thrombotique : héparine curative ± aspirine - Si SAPL obstétrical ou discuté si SAPL biologique triple positif : héparine préventive + aspirine	

Contexte			A vie	Lors d'une grossesse
SAPL	Prouvé	Thrombotique	AVK	Héparine curative ± Aspirine
		Récidive	↗ AVK ou AVK + aspirine	
		Obstétrical	Aspirine	Aspirine + héparine préventive
	Biologique	Associé à un lupus	Aspirine	Aspirine
		Isolé	Discuter aspirine	Aspirine
		Triple positif	idem	Aspirine + héparine iso-coagulante